

Эректильная дисфункция (ED)

Информация для пациента · Распространённая и хорошо поддающаяся лечению проблема — и сигнал для сердца

WARWIKI

Эректильная дисфункция (ED) — это затруднение с достижением или поддержанием эрекции, достаточной для полноценного полового акта. Состояние очень распространено и встречается чаще с возрастом, однако оно хорошо поддаётся лечению. Поскольку эрекция зависит от нормального кровотока, ED может быть **ранним признаком** заболеваний сердца и сосудов — и это весомый повод для обследования.

Причины

Для эрекции необходимы здоровые сосуды, нервы, гормоны и психологическое состояние. Как правило, причин бывает несколько:

- **Кровоток** (наиболее частая причина) — общие факторы риска с сердечными болезнями: диабет, высокое давление, высокий холестерин, курение, избыточный вес.
- **Нервы** — после операций на простате или органах малого таза, при диабете, заболеваниях позвоночника.
- **Гормоны** — низкий тестостерон.
- **Лекарства и психозэмоциональные факторы** — ряд препаратов, стресс, тревога, депрессия, проблемы в отношениях.

Проверка здоровья сердца

Небольшие артерии полового члена могут первыми реагировать на сосудистые нарушения. Новая ED — повод проверить давление, сахар и холестерин: лечение этих факторов улучшает и здоровье сердца, и качество эрекции.

ТЕРМИНЫ

Эректильная дисфункция (ED)

Затруднение с достижением или поддержанием эрекции для полового акта.

Сосудистая причина

Нарушение кровотока — наиболее частая причина ED.

Ингибитор PDE5

Таблетки первой линии от ED (силденафил, тадалафил и др.).

Вакуумное устройство (VED)

Помпа, нагнетающая кровь в половой член для создания эрекции.

Интракавернозная инъекция

Самоинъекция, вызывающая эрекцию.

Протез полового члена

Хирургическое устройство при ED, не поддающейся другим методам.

МОЖНО ЛИ ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ? Почти всегда — да. ED — одно из наиболее поддающихся лечению состояний в мужском здоровье. Лечение строится по принципу **лестницы**: начинают с простого и переходят к следующему шагу лишь при необходимости. Эффективный вариант есть на каждом уровне.

Как это лечат (шаг за шагом)

- 1 **Образ жизни и здоровье** — физическая активность, снижение веса, отказ от курения, контроль диабета и давления реально улучшают эрекцию; пересмотрите принимаемые препараты.
- 2 **Таблетки (ингибиторы PDE5)** — стандартный первый шаг лечения.
- 3 **Вакуумное устройство, инъекции или уретральный суппозиторий** — эффективные варианты, если таблетки не помогают.
- 4 **Тестостерон** при его дефиците; **психологическая помощь** при стрессе или проблемах в отношениях.
- 5 **Протез полового члена** — надёжный хирургический вариант при неэффективности других методов. По каждому варианту есть отдельный листок.

Как это диагностируют

- Сбор анамнеза (включая сердечно-сосудистые риски и принимаемые лекарства) и осмотр
- Анализы крови — сахар, тестостерон, холестерин

Важно знать

- Открытый разговор с партнёром и работа с тревогой или настроением значительно помогают.
- Остерегайтесь непроверенных «добавок» из интернета — некоторые содержат скрытые лекарственные вещества.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- ED сочетается с **болью в груди** или одышкой при нагрузке — нужна кардиологическая проверка
- ED началась **внезапно после травмы** таза или полового члена
- На фоне лечения: эрекция длится **более 4 часов** (неотложная ситуация)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. ED очень распространена и хорошо поддаётся лечению — от таблеток до протеза есть эффективный вариант на каждом шагу.
2. ED может быть ранним признаком сердечно-сосудистого заболевания — обследование полезно для общего здоровья, а изменение образа жизни улучшает эрекцию.
3. Поговорите с вашей лечащей командой. Обратитесь за помощью при ED с болью в груди или эрекции более 4 часов на фоне лечения.